TFR 档案 档案 A · 患者本人视角 | HVT-08 | 本页零判读

核对状态（照抄）

核对状态：未开始核对

> **本页不提供 AI 生成。**红线：停药相关重大决策不 AI 生成；页面内容只做事实照抄与问题清单，决策由你与医生完成。

“先把 MMR 稳住”

来源：医生原话 · 血液科门诊 2026-10-12

> 本页只做两件事：① 列出「指南 / 门诊书面条件条目」并给出它照抄自哪份记录；② 记录这个字段在你报告里出现了吗（三态：已抄录 / 未抄录 / 待补）。本页不判断这些条件是否成立，也不给任何停药或继续用药的方向；页内医生原话一律带来源、只作留档。

指南书面条件原文如未逐字核对入库，条目来源处写「待补（本仓不代拟）」；不臆造原文。

必备 5 条

报告字段照抄位 + 三态

书面条件条目（照抄报告字段）	这个字段在报告里出现了吗（三态可切换）	照抄自 / 说明（照抄原文，本仓不判读）
首次慢性期诊断 书面条件条目照抄自：血液科 2026-01-22	已抄录 未抄录 待补 当前：已抄录	血液科 2026-01-22
患者有停药意愿且沟通良好 书面条件条目照抄自：本档案尚未抄录该条件的书面原文（待补，本仓不代拟）	已抄录 未抄录 待补 当前：未抄录	报告里尚未抄录该字段（待补）
可靠定量方法（灵敏度至少 MR4.5） 书面条件条目照抄自：省血液病医院 2026-10-12	已抄录 未抄录 待补 当前：已抄录	省血液病医院 2026-10-12
非典型转录本需高标准实验室 书面条件条目照抄自：本例为典型 e14a2	已抄录 未抄录 待补 当前：待补	本例为典型 e14a2
同意停药后接受更频繁监测 书面条件条目照抄自：本档案尚未抄录该条件的书面原文（待补，本仓不代拟）	已抄录 未抄录 待补 当前：未抄录	报告里尚未抄录该字段（待补）

最低 5 条

第 5 行为最佳项

书面条件条目（照抄报告字段）	这个字段在报告里出现了吗（三态可切换）	照抄自 / 说明（照抄原文，本仓不判读）
一线治疗或敏感突变换二线 书面条件条目照抄自：一线伊马替尼→不耐受换达沙替尼	已抄录 未抄录 待补 当前：已抄录	一线伊马替尼→不耐受换达沙替尼

书面条件条目（照抄报告字段）	这个字段在报告里出现了吗（三态可切换）	照抄自 / 说明（照抄原文，本仓不判读）
典型 e13a2/e14a2 转录本 书面条件条目照抄自：2026-01-22 RT-PCR	已抄录 未抄录 待补 当前：已抄录	2026-01-22 RT-PCR
TKI 治疗 > 5 年（二代 > 4 年） 书面条件条目照抄自：截至 2026-10 已用药 9 个月（本仓只抄时长，不判是否够）	已抄录 未抄录 待补 当前：未抄录	截至 2026-10 已用药 9 个月（本仓只抄时长，不判是否够）
DMR（MR4.0 或更好）持续 > 2 年 书面条件条目照抄自：最近 IS 0.086%（报告值，本仓不换算是否达某档）	已抄录 未抄录 待补 当前：未抄录	最近 IS 0.086%（报告值，本仓不换算是否达某档）
最佳：MR4.5 持续 > 2 年 书面条件条目照抄自：本档案尚未抄录该条件的书面原文（待补，本仓不代拟）	已抄录 未抄录 待补 当前：未抄录	报告里尚未抄录该字段（待补）

最佳项 单列

书面条件条目	最佳：MR4.5 持续 > 2 年 书面条件条目照抄自：本档案尚未抄录该条件的书面原文（待补，本仓不代拟）
这个字段在报告里出现了吗	未抄录
照抄自 / 说明	报告里尚未抄录该字段（待补）

已抄录 未抄录 待补

单列只为排版，不代表条件的成立与否。

密测轨道（三行）

轨道	监测频率（照抄书面口径）	进度（照抄门诊记录）
停药后前 6 个月	每 1–2 个月 1 次分子学监测	未开始
第 7–12 个月	每 2 个月 1 次	未开始
之后（无限期）	保持 MMR 者每 3 个月 1 次	未开始

> 轨道只显示排期与进度，不给「是否该继续监测」的判断；血常规密测轨道见分子线二级页「复查记录 CML-LAB」。

去复查记录 CML-LAB（血常规密测轨道）

门诊记录引用（仅医生原话 + 来源）

本档案门诊记录中无常停药相关原话引用；待门诊补录。

引用只为留档：医生原话原样照抄并带来源，本页不据此给任何处置方向。

导出核对清单（去诊室用）

三块：必备 / 最低 / 门诊原话

导出只含「报告字段照抄位 + 核对状态 + 医生原话与来源」，本清单不给结论。

导出核对清单　打印这一页

```
TFR 核对清单（档案 A · 患者本人视角）
导出时间：2026-10-13 · 只含报告字段照抄位与医生原话，本清单不给结论

【必备 5 条】
1. 首次慢性期诊断 | 报告原文值：已确认 | 核对三态：已抄录
2. 患者有停药意愿且沟通良好 | 报告原文值：未确认 | 核对三态：未抄录
3. 可靠定量方法（灵敏度至少 MR4.5） | 报告原文值：已确认 | 核对三态：已抄录
4. 非典型转录本需高标准实验室 | 报告原文值：不适用 | 核对三态：待补
5. 同意停药后接受更频繁监测 | 报告原文值：未确认 | 核对三态：未抄录

【最低 5 条】
1. 一线治疗或敏感突变换二线 | 报告原文值：已确认 | 核对三态：已抄录
2. 典型 e13a2/e14a2 转录本 | 报告原文值：已确认 | 核对三态：已抄录
3. TKI 治疗 > 5 年（二代 > 4 年） | 报告原文值：未抄录 | 核对三态：未抄录
4. DMR（MR4.0 或更好）持续 > 2 年 | 报告原文值：未抄录 | 核对三态：未抄录
5. 最佳：MR4.5 持续 > 2 年 | 报告原文值：未抄录 | 核对三态：未抄录

【门诊原话（带来源）】
· 白细胞和血小板都低了，先减到 300mg 观察（来源：血液科门诊 2026-05-08 · 文件 A-D3）
· 胸腔积液考虑和伊马替尼无关，换达沙替尼，先用 50mg（来源：血液科门诊 2026-08-15 · 文件 A-D5）
```

手工入口

⋯ 更多